

Revisi 01_ARTIKEL ABSTRAK DAN INTI SARI KONFERENCE TAHUN 2025,,.docx

by Turnitin No Repository

Submission date: 02-Feb-2026 10:11AM (UTC+0900)

Submission ID: 2868212012

File name: Revisi_01_ARTIKEL_ABSTRAK_DAN_INTI_SARI_KONFERENCE_TAHUN_2025_.docx (113.17K)

Word count: 2753

Character count: 18105

ANALISIS BIAYA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIAYA PENYAKIT HIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT BALARAJA BPJS PADA TAHUN 2023

Endang Sunariyanti^{1*}
Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
email : endangsunariyanti@gmail.com

Murhasdi²
Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
email: murhasdi26@gmail.com

Nuriyatul Fhatonah³
Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
email: nuriyatulfhatonah0207@gmail.com

Corresponding Author: Endang Sunariyanti, Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin, Jl. KH. Syekh Nawawi KM 4 No.13, Matagara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Emil: endang_sunariyanti@gmail.com

ABSTRAK

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi beban utama bagi sistem kesehatan di Indonesia, termasuk di RSUD Balaraja. Tingginya prevalensi hipertensi dan kebutuhan pelayanan kesehatan jangka panjang menuntut analisis biaya yang komprehensif untuk mengevaluasi efisiensi pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya riil penyakit hipertensi pada pasien rawat jalan di RSUD Balaraja tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan adanya disparitas yang bermakna antara beban biaya aktual rumah sakit dan kompensasi dari sistem INA-CBGs. Temuan ini merekomendasikan perlunya optimalisasi diagnosis, efisiensi penggunaan sumber daya, dan penyesuaian tarif INA-CBGs khususnya untuk kasus hipertensi dengan komorbiditas. Implikasi penelitian ini penting untuk pengambilan kebijakan manajemen pembiayaan hipertensi di tingkat rumah sakit daerah dan evaluasi sistem JKN secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan biaya riil rata-rata per kunjungan pasien hipertensi sebesar Rp.185.198, dengan komponen terbesar berasal dari obat-obatan (43,73%) dan pemeriksaan laboratorium (29,26%). Faktor yang secara signifikan memengaruhi tingginya biaya adalah adanya komorbiditas seperti diabetes dan penyakit ginjal, yang meningkatkan biaya sebesar 30-50% dibandingkan pasien tanpa komorbiditas.

Kata Kunci : Analisis biaya, hipertensi, INA-CBGs, biaya riil, RSUD Balaraja, pembiayaan kesehatan.

COST ANALYSIS AND FACTORS INFLUENCING THE COST OF HYPERTENSION IN OUT PATIENTS AT BALARAJA BPJS HOSPITAL IN 2023

¹ **Endang Sunariyanti¹**
Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
email : endang sunariyanti@gmail.com

¹ **Murhasdi²**
Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
email: murhasdi26@gmail.com

¹ **Nuriyatul Fhatonah³**
Fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
email: nuriyatulfhatonah0207@gmail.com

Corresponding Author: Endang Sunariyanti, Fakultas ²farmasi Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin, Jl. KH. Syekh Nawawi KM 4 No.13, Matagara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Emil: endang ²sunariyanti@gmail.com

ABSTRACT

Hypertension is one of the non-communicable diseases that poses a major burden on the health system in Indonesia, including at Balaraja Regional General Hospital. The high prevalence of hypertension and the need for long-term health services require a comprehensive cost analysis to evaluate financing efficiency. This study aims to analyze the real costs of hypertension in outpatient patients at Balaraja Regional General Hospital in 2023. The study concludes that there is a significant disparity between the actual hospital cost burden and compensation from the INA-CBGs system. These findings recommend the need to optimize diagnosis, efficiency in resource use, and adjustments to INA-CBGs rates, especially for cases of hypertension with comorbidities. The implications of this research are important for hypertension financing management policy making at the district hospital level and the national evaluation of the JKN system. The research results show that the average real cost per visit for hypertension patients is Rp. 185,198, with the largest components coming from medications (43.73%) and laboratory tests (29.26%). Factors that significantly influence the high costs include the presence of comorbidities such as diabetes and kidney disease, which increase costs by 30-50% compared to patients without comorbidities.

Keywords : Cost analysis, hypertension, INA-CBGs, real costs, Balaraja Regional Public Hospital, health financing.

A. PENDAHULUAN

Hipertensi masih menjadi salah satu isu kesehatan paling penting karena prevalensinya sangat besar dan kontrol tekanan darah masih rendah. WHO melaporkan bahwa pada 2024¹¹ terdapat sekitar 1,4 miliar orang dewasa usia 30–79 tahun yang hidup dengan hipertensi, dengan proporsi yang tidak kecil belum terdiagnosis maupun terkontrol. Kondisi ini berdampak pada peningkatan risiko kejadian kardiovaskular dan kebutuhan pelayanan jangka panjang, sehingga memperbesar beban sistem kesehatan (World Health Organization, 2025).

Di Indonesia, persoalan hipertensi tidak hanya terkait besarnya prevalensi, tetapi juga rendahnya kinerja care cascade (diagnosis–terapi–kontrol). Bukti survei nasional berulang menunjukkan prevalensi hipertensi meningkat hingga 2023, namun capaian diagnosis dan terutama kontrol tetap rendah; hal ini mengindikasikan sebagian besar kasus belum tertangani optimal dan berpotensi mendorong kebutuhan layanan berkelanjutan, pemantauan rutin, dan penggunaan obat kronis (Muharram et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi kesehatan, beban biaya hipertensi semakin kompleks ketika pasien memiliki komorbiditas. Literatur terbaru menunjukkan bahwa multimorbiditas berkaitan dengan peningkatan kebutuhan layanan (kunjungan, obat, pemeriksaan, dan rujukan), sehingga mendorong biaya langsung medis menjadi lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa komorbiditas. Dengan demikian, analisis biaya penyakit (misalnya biaya riil/biaya aktual) penting untuk mengidentifikasi komponen biaya dominan dan faktor klinis yang menjadi cost driver (Tran et al., 2022).

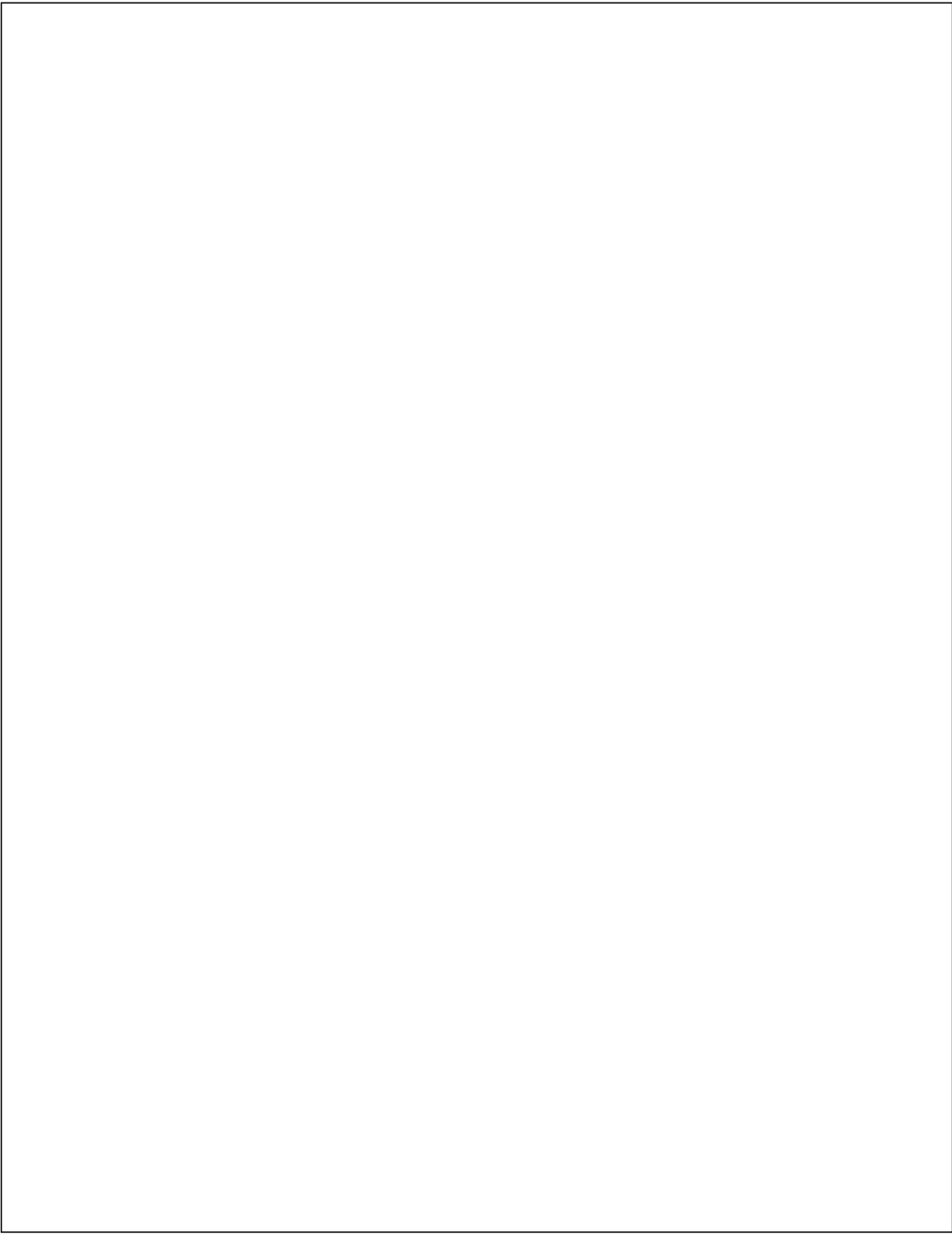
Dalam konteks Indonesia, pembiayaan layanan rujukan JKN pada FKRTL menggunakan metode pembayaran berbasis INA-CBG yang diatur dalam regulasi Kementerian Kesehatan. Regulasi tersebut menegaskan INA-CBG sebagai acuan pembayaran klaim, sekaligus

menyinggung perlunya penyesuaian pedoman karena dinamika kebutuhan pelayanan, termasuk isu pengodean yang dapat memicu *dispute* dan penundaan klaim (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Sejalan dengan itu, beberapa bukti empiris di tingkat rumah sakit menunjukkan potensi disparitas ⁵ antara biaya riil dan tarif INA-CBG; misalnya pada pasien hipertensi rawat inap, total biaya riil dilaporkan ⁷ lebih tinggi daripada total tarif INA-CBG sehingga terjadi selisih negatif (Restyana et al., 2024).

Berangkat dari keterbatasan bukti mengenai ⁵ analisis biaya riil hipertensi pada layanan rawat jalan dalam konteks pembiayaan BPJS, naskah ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan kajian ⁵ pada pasien hipertensi rawat jalan di RSUD Balaraja tahun 2023 serta menyajikan pemetaan komponen biaya langsung medis yang membentuk total biaya, seperti obat dan pemeriksaan laboratorium. Selain itu, naskah ini mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan variasi biaya antar pasien, termasuk kondisi klinis penyerta (komorbiditas), untuk menjelaskan perbedaan beban biaya yang muncul dalam praktik layanan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menentukan biaya total penyakit hipertensi pada pasien rawat jalan peserta BPJS di RSUD Balaraja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi besarnya biaya pada pasien tersebut.

⁸ B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional study menurut perspektif rumah sakit. ⁶ Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non random sampling dengan metode purposive sampling. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien peserta JKN dengan diagnosa penyakit hipertensi yang dirawat di Rumah Sakit Balaraja pada tahun 2023.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pasien

Karakteristik pasien dikelompokkan menjadi beberapa diantaranya jenis kelamin, usia, klasifikasi penyakit penyerta dan klasifikasi hipertensi.

10 a. Jenis Kelamin dan usia

Tabel 1. Distribusi jenis kelamin pasien hipertensi dan Distribusi usia pasien hipertensi rawat jalan

No	Jenis kelamin	Jumlah Pasien	%
1	Perempuan	48	66
2	Laki laki	24	33
	Jumlah	72	100

No	Umur (Tahun)	Jumlah Pasien	%
1	31-40	5	7
2	41-50	15	20
3	51-60	27	37
4	61-70	19	26
5	>70	6	8
	Jumlah 72		100%

Berdasarkan tabel 1 dan 2 karakteristik pasien pada bagian hasil, sampel didominasi perempuan sebesar 66,7% (n=48) dibanding laki-laki 33,3% (n=24) dan terkonsentrasi pada usia paruh baya hingga lansia, terutama kelompok 51–60 tahun sebesar 37% (n=27) serta 61–70 tahun sebesar 26% (n=19), diikuti 41–50 tahun 20% (n=15), >70 tahun 8% (n=6), dan 31–40 tahun 7% (n=5). Secara ilmiah, dominasi kasus pada usia lebih tua konsisten dengan proses penuaan vaskular yang meningkatkan kekakuan arteri dan resistensi perifer sehingga tekanan darah lebih mudah meningkat. Selain itu, lintasan risiko hipertensi pada perempuan dapat meningkat setelah menopause, sehingga kebutuhan pemantauan dan terapi jangka panjang juga dapat bertambah pada

kelompok ini (Huegli & Pechère-Bertschi, 2023; Qi et al., 2024).

b. Klasifikasi Hipertensi

Tabel 3. Klasifikasi derajat hipertensi pasien

No.	klasifikasi	jumlah	%
1	Stage 1	18	25
2	Stage 2	30	41,66
3	Krisis	24	33,33
Jumlah		72	100%

Pada klasifikasi hipertensi tabel 3 diatas, proporsi stage 2 sebesar 41,66% (n=30) dan krisis sebesar 33,33% (n=24) lebih besar dibanding stage 1 sebesar 25% (n=18). Pola ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa banyak pasien datang dalam kondisi tekanan darah yang belum terkontrol atau sudah memburuk. Temuan tersebut sejalan dengan bukti nasional bahwa tingkat kontrol hipertensi di Indonesia masih rendah meskipun cakupan pengobatan meningkat, sehingga sebagian besar penderita tetap berada pada kategori tidak terkontrol dan berpotensi membutuhkan intensitas layanan lebih tinggi (Muharram et al., 2025). Dalam praktik layanan, derajat hipertensi yang lebih berat dapat meningkatkan kebutuhan konsultasi, penyesuaian regimen, serta pemeriksaan penunjang untuk menilai risiko dan komplikasi.

c. Klasifikasi Penyakit Penyerta (Komorbid)

Tabel 4. Klasifikasi Penyakit Penyerta Pasien

No.	Penyakit penyerta	Jumlah	%
1.	1	41	58,57
2.	2	12	16,66
3.	3	7	9,72
4	Tanpa penyakit penyerta	12	16,66
Jumlah		72	100%

Profil penyakit penyerta pada tabel 4 komorbid (penyakit penyerta) menunjukkan bahwa mayoritas pasien memiliki setidaknya satu komorbid, yaitu 83,33% pasien memiliki ≥ 1 komorbid; rinciannya 1 komorbid sebesar 58,57% (n=41), 2 komorbid 16,66% (n=12), dan 3 komorbid 9,72% (n=7), sementara pasien tanpa komorbid hanya 16,66% (n=12). Dari perspektif ekonomi kesehatan, multimorbiditas meningkatkan kompleksitas tata laksana karena pasien cenderung membutuhkan obat tambahan di luar antihipertensi, pemeriksaan laboratorium lebih sering (misalnya monitoring metabolik dan fungsi ginjal), serta kunjungan klinis yang lebih intensif. Sintesis bukti menunjukkan biaya multimorbiditas umumnya lebih tinggi dibanding kondisi tunggal dan sangat bervariasi menurut kombinasi penyakit serta konteks sistem kesehatan (Tran et al., 2022). Pada populasi lansia dengan hipertensi, multimorbiditas juga dilaporkan meningkatkan beban pengeluaran kesehatan, dengan penyakit jantung atau diabetes dapat menjadi penggerak biaya utama tergantung negara (Phuong et al., 2025).

2. Jenis Obat Hipertensi Yang Digunakan

Tabel 5. Frekuensi obat yang diresepkan pada pasien hipertensi rawat jalan

No.	Nama Obat	Jumlah R/
1	Amlodipine 10 mg	53
2	Amlodipine 5 mg	7
3	Atorvastatin 20 mg	3
4	Bisoprolol 5 mg	8
5	Bisoprolol 2,5 mg	7
6	Candesartan 16 mg	25
7	Candesartan 8 mg	24
8	Captopril 12,5 mg	1
9	Clonidine 0,15 mg	5
10	Furosemide 40 mg	7
11	Propanolol 10 mg	2
12	Spironolactone 100 mg	1

Pola persepsan yang ditunjukkan pada tabel 5 memperlihatkan dominasi penggunaan amlodipine sebanyak 60 resep dan candesartan sebanyak 58 resep, diikuti bisoprolol 25 resep, captopril 18 resep, serta lisinopril 2 resep. Secara klinis, pola ini lazim pada praktik rawat jalan karena golongan calcium channel blocker (CCB) dan angiotensin receptor blocker (ARB) sering digunakan untuk mencapai target tekanan darah dan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari terapi kombinasi pada pasien dengan derajat hipertensi yang lebih berat. Namun, keberadaan

komorbiditas berpotensi meningkatkan kebutuhan obat lain non-antihipertensi (misalnya terapi untuk keluhan gastrointestinal, diabetes, atau penyakit ginjal), yang pada akhirnya memengaruhi komponen biaya non-antihipertensi (Kwakye et al., 2024). Secara lebih luas, multimorbiditas juga berkaitan dengan polypharmacy dan adanya komorbid kunci seperti diabetes dan CKD yang dapat memengaruhi kontrol tekanan darah dan menambah kebutuhan obat/monitoring lain; konsekuensinya, komponen biaya non-antihipertensi dapat meningkat (Ji et al., 2023).

3. Analisis Biaya

Tabel 6. Struktur biaya langsung medis pasien hipertensi rawat jalan

No.	Jenis biaya	Total	Jumlah Pasien	Rata-Rata	(%)
1	Obat Hipertensi	Rp.2.485.446	72	Rp.34.520	18,63
2	Obat lainnya	Rp.3.346.900	72	Rp.46.484	25,09
3	Laboratorium	Rp.3.902.000	72	Rp.54.194	29,26
4	Konsultasi dokter spesialis	Rp.3.600.000	72	Rp.50.000	26,99
Jumlah		Rp.13.334.346		Rp.185.198	100%

Selanjutnya, pada tabel 6 analisis biaya menunjukkan total biaya langsung medis hipertensi rawat jalan pada sampel tahun 2023 sebesar Rp13.334.346 dengan rata-rata Rp185.198 per pasien. Struktur biaya memperlihatkan bahwa komponen dengan kontribusi terbesar adalah obat-obatan, dimana obat antihipertensi sebesar Rp2.485.446 (18,63%) dengan obat non-antihipertensi/obat lainnya sebesar Rp3.346.900 (25,09%), total biaya obat mencapai Rp5.832.346 (43,72%), sehingga persentasenya lebih tinggi. Setelah obat-obatan, komponen terbesar berikutnya adalah

pemeriksaan laboratorium sebesar Rp3.902.000 (29,26%; rata-rata Rp54.194/pasien), sedangkan konsultasi dokter spesialis berkontribusi Rp3.600.000 (26,99%; rata-rata Rp50.000/pasien). Dominasi biaya obat terutama berasal dari obat non-antihipertensi diikuti oleh tingginya biaya laboratorium menunjukkan bahwa beban pembiayaan hipertensi rawat jalan tidak hanya dipengaruhi terapi penurunan tekanan darah, tetapi juga kebutuhan terapi tambahan dan monitoring klinis yang menyertai kondisi pasien. Pola komponen biaya ini sejalan dengan studi rawat jalan yang melaporkan bahwa biaya langsung medis hipertensi umumnya tersusun dari biaya obat, pemeriksaan penunjang/laboratorium, serta layanan klinis (misalnya konsultasi) dan/atau administrasi (Dalaba et al., 2025; Nilansari et al., 2024).

4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Analisis Biaya

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan variasi biaya medis harian pada pasien hipertensi berdasarkan karakteristik demografis dan klinis. Temuan yang paling mencolok adalah tingginya biaya medis pada kelompok usia termuda (31-40 tahun) sebesar Rp.298.349 per hari, yang justru lebih tinggi dibanding kelompok usia lebih tua. Fenomena ini mungkin mencerminkan beberapa faktor kompleks, termasuk kecenderungan hipertensi sekunder yang memerlukan pemeriksaan diagnostik lebih intensif pada usia muda, pendekatan terapi yang lebih agresif oleh klinisi untuk pasien usia produktif, serta potensi ketidakpatuhan pengobatan yang menyebabkan perburukan kondisi (Mikhaylova & Krikova, 2022)

Pada analisis berdasarkan jenis kelamin, meskipun tidak signifikan secara statistik, perempuan menunjukkan biaya lebih tinggi (Rp177.025) dibanding laki- laki (Rp129.462), yang mungkin terkait dengan perbedaan pola pemanfaatan layanan kesehatan dan profil komorbiditas spesifik gender. Yang tak kalah penting adalah temuan bahwa pasien dengan komorbiditas

memerlukan biaya 42% lebih tinggi, menyoroti dampak signifikan penyakit penyerta terhadap beban ekonomi penanganan hipertensi. Pola biaya yang relatif seragam antar stadium hipertensi (stage 1: Rp172.604; stage 2: Rp169.440; krisis: Rp148.950) mengindikasikan kemungkinan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya, di mana penanganan kasus berat tidak secara proporsional mendapatkan alokasi yang lebih besar (Ipinnimo et.al., 2023)

Temuan-temuan ini secara kolektif menegaskan perlunya pendekatan manajemen hipertensi yang lebih personalisasi, dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik pasien seperti usia, jenis kelamin, dan ada tidaknya komorbiditas, untuk mencapai optimalisasi outcomes klinis sekaligus efisiensi biaya.

Tabel 7. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap analisis biaya

Variabel	Kelompok	Jumlah pasien	Rata rata biaya medis perhari (Rp)	P
Jenis kelamin	Perempuan	48	177,025	0,385
	Laki-laki	24	129,462	
Umur	31-40	5	298,349	0,417
	41-50	15	153,628	
	51-60	27	184,685	
	61-70	19	125,249	
	>70	6	73,653	
hipertensi	Stage 1	18	172,604	0,935
	Stage 2	30	169,440	
	Krisis	24	148,950	
Penyakit penyerta	Tanpa penyakit penyerta	12	111,105	0,361
	Dengan penyakit penyerta	60	157,571	

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis biaya riil hipertensi rawat jalan pada pasien peserta BPJS di RSUD Balaraja tahun 2023,

1. Cost of illness penyakit hipertensi pasien rawat jalan di Rumah sakit kabupaten balaraja pada pasien BPJS tahun 2023 dengan total biaya sebesar Rp.13.334,346 dengan nilai rata-rata sebesar Rp.185.198 setiap pasiennya. Komponen pengeluaran terbesar berasal

dari biaya obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium. kontribusi terbesar berasal dari obat non-antihipertensi (obat lainnya), yang menunjukkan bahwa beban biaya pada pasien hipertensi tidak hanya dipengaruhi terapi penurunan tekanan darah, tetapi juga oleh kebutuhan terapi tambahan terkait keluhan dan/atau komorbiditas. Selain obat, komponen besar berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium, yang menguatkan bahwa kebutuhan monitoring klinis turut menjadi penggerak biaya penting pada layanan pasien hipertensi rawat jalan.

2. Tidak terdapat faktor yang signifikan yang mempengaruhi biaya pasien rawat jalan penyakit hipertensi di rumah sakit balaraja pada pasien BPJS tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Dalaba, M. A., Doegah, P. T., Folsom, A., Immurana, M., Ayanore, M. A., Akazili, J., Bosu, W. K., & Edwin, F. (2025). Economic burden of hypertension to outpatients attending the Ho Teaching Hospital in the Volta Region of Ghana: A cross-sectional study. *BMC Health Services Research*, 25, 1116. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-13338-9>
- Huegli, S., & Giannattasio, C. (2023). Hypertension in women: What is different? *Diseases*, 11(3), 74. <https://doi.org/10.3390/diseases11030074>
- Ji, E., Ahn, S., Choi, J. Y., Kim, C. H., & Kim, K. I. (2023). Effect of multimorbidity on hypertension management. *Scientific reports*, 13(1), 18764. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-44813-0>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan.
- Kwakye, A. O., Kretchy, I. A., & Oppong, K. G. (2024). Polypharmacy and its associated factors among patients with co-morbid hypertension and diabetes in a municipal hospital in Ghana. *Scientific African*, 23, e02028. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e02028>
- Muharram, F. R., Widyahening, I. S., & Danaei, G. (2025). Hypertension care performance in Indonesia: evidence from three waves of nationally representative cross-sectional surveys. *BMJ Open*, 15(12), e109588. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-109588>
- Nilansari, A. F., Wahid, R. A. H., & Fatimah, F. A. (2024). Clinical outcomes: Analysis of quality of life and direct medical costs of outpatient hypertensive patients at Panembahan Senopati Hospital, Indonesia. *Journal of Public Health and Development*, 22(1), 145–156. <https://doi.org/10.55131/jphd/2024/220111>
- Phuong, N. K., Giang, N. H., Li, H., Vinh, N. T., Oanh, T. T. M., & Wu, C. (2025). Economic burdens of health expenditure for multi-morbidity of older people with hypertension in China and Vietnam. *Frontiers in Public Health*, 13, 1666119. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1666119>
- Qi, H. U. A., Li, F. A. N., Zeng-Wu, W. A. N. G., & Jing, L. I., (2024). 2023 Guideline for the management of hypertension in the elderly population in China. *Journal of Geriatric Cardiology*, 21(6), 589–630. <https://doi.org/10.26599/1671-5411.2024.06.001>
- Restyana, A., Admaja, W., & Puspiana, R. (2024). Suitability of real cost to tariff of INA-CBGs of hypertensive patients at X general hospital. *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 10(1), 24–30. <https://doi.org/10.35311/jmpi>
- Tran, P. B., Kazibwe, J., Nikolaidis, G. F., Linnosmaa, I., Rijken, M., & van Olmen, J. (2022). Costs of multimorbidity: a systematic review and meta-analyses. *BMC Medicine*, 20(1).

<https://doi.org/10.1186/s12916-022-02427-9>

World Health Organization. (2025), Hypertension. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

World Health Organization. (2025, September 25). *Hypertension* (Fact sheet).

Revisi 01_ARTIKEL ABSTRAK DAN INTI SARI KONFERENCE TAHUN 2025,,,docx

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.ummat.ac.id

Internet Source

2%

2

ejournal.poltekkes-smg.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.poltekkes-denpasar.ac.id

Internet Source

1%

4

Aris Fadillah. "ANALISIS FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI BIAYA TERAPI PENYAKIT
HIPERTENSI PADA PASIEN RAWAT INAP
RUMAH SAKIT X", Jurnal Farmasi Islam
Kalimantan, 2024

Publication

1%

5

Isma Oktadiana. "The Analysis of Reliability
Costs Toward INA-CBGS Rates in Patients
With Hypertension in Pandan Arang Boyolali
District Hospital In 2017", Jurnal Farmasi
Indonesia, 2019

Publication

1%

6

Ade Nuriah Amin, Yupi Supartini, Eviana
Sumarti Tambunan, Titi Sulastri, Ratna
Ningsih, Dina Carolina Hapsari. "Analysis of
Factors That Influence Bullying Behavior in
Adolescents in Public Middle School in East
Jakarta Region", JKEP, 2024

Publication

1%

7

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%

8

media.neliti.com

Internet Source

1 %

9

Wahyudi Wahyudi, Diani Sari Panggabean,
Dwi Syahputri Purba, Jihan Mawaddah Pane,
Meutia Hafni Indah Triana, Putri Adinda.

"ANALISIS BIAYA LANGSUNG MEDIS TERAPI
ANTIDIABETES ORAL PADA PASIEN DIABETES
MELITUS TIPE 2 RAWAT JALAN", PREPOTIF :
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2024

Publication

1 %

10

docobook.com

Internet Source

1 %

11

journal.lppm-unasman.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On